要介護認定調査票・ペルソナ症例 09

要介護認定基本調査・主治医意見書・概況調査統合データファイル

1. 調査実施者および調査対象者の情報

調査対象者氏名	小林 フミ（こばやし ふみ）	**年齢 / 性別**	89歳 / 女性
要介護度	要介護4	**調査実施者**	地域包括支援センター職員（社会福祉士）

2. 現在受けているサービスの状況（概況調査）

【在宅利用・介護給付】通所介護（デイサービス）週5日、短期入所生活介護月8日、訪問介護（1日複数回）、福祉用具貸与（車椅子・特殊寝台）

3. 置かれている環境等（家族・居住環境・傷病等）

【家族状況】夫（90歳・要支援1）と二人暮らしの「老老＆認認（夫婦ともに認知症）」世帯。子どもは関東圏に在住。
【居住環境】平屋の持ち家。
【主な介護者】夫（90歳・本人も要支援で介護能力不十分）。
【傷病・既往歴】脳出血後遺症（左片麻痺）、アルツハイマー型認知症（中等度〜重度）。

4. 主治医意見書（医学的記載事項）

主傷病名	脳出血後遺症（左片麻痺）、アルツハイマー型認知症（中等度〜重度）
傷病の経過・治療内容	左片麻痺による運動機能障害に加え、中等度〜重度の認知症が進行。夫（90歳・要支援1）と二人暮らしの老老世帯であり、日常生活管理が完全に崩壊している。
医学的管理の必要性	抗血小板薬、降圧薬の内服管理（自己管理絶対不可能）。左片麻痺に対する機能維持訓練、定期的な訪問診療および血圧測定。
身体障害に関する意見	左上下肢に片麻痺あり。立位保持は不安定で転倒リスクが高い。移動には見守りおよび一部〜全介助を要する。
精神・認知機能の意見	中等度〜重度の認知症。見当識障害、短期記憶の欠如、徘徊、過量服薬未遂、夜間不穏、被害妄想、不潔行為等のBPSDが頻発。
特別医療・ケアの必要性	服薬管理、火の元管理、排泄・入浴管理のすべてにおいて医療・介護の全面的な介入が必要。
介護に関する医学的意見	夫（90歳）も軽度認知機能低下があり、夫婦ともに認知症（老老＆認認）であるため在宅での安全確保が極めて困難。デイサービス週5日およびショートステイ、訪問介護

	をフル活用しつつ、特別養護老人ホームへの入所手続きを急ぐべき緊急度の高いケース。

5. 要介護認定基本調査（全74項目）

第1群：身体機能・起居動作（全13項目）

1. 麻痺（上肢）：左片麻痺あり (4)
2. 麻痺（下肢）：左片麻痺あり (4)
3. 関節拘縮（上肢）：左肘・手関節に軽度拘縮 (2)
4. 関節拘縮（下肢）：なし (1)
5. 寝返り：一部介助 (2)
6. 起き上がり：一部介助 (2)
7. 座位保持：自立 (1)
8. 立位保持：不安定（左片麻痺のため転倒リスク高） (3)
9. 歩行：一部介助（杖や手すり、見守り歩行） (3)
10. 立ち上がり：一部介助 (2)
11. 片足立ち：不可能 (4)
12. 洗顔：一部介助（右手のみで行うが手順曖昧） (2)
13. 爪切り：全介助 (4)

第2群：生活機能（全12項目）

1. 移乗：一部介助 (2)
2. 移動（屋内）：一部介助（左片麻痺と認知症による道迷い注意） (3)
3. 移動（屋外）：全介助（車椅子または付き添い） (4)
4. 食事摂取：一部介助（途中で遊び出すことあり） (2)
5. 排泄（トイレ動作）：一部介助（ポータブルトイレ誘導、オムツ併用） (3)
6. 排泄（排便コントロール）：一部介助 (2)
7. 衣服着脱（上衣）：全介助 (4)
8. 衣服着脱（ズボン等）：全介助 (4)
9. 入浴：全介助 (4)
10. 口腔清潔：全介助 (4)
11. 洗髪：全介助 (4)
12. 買い物：できない (4)

第3群：認知機能（全9項目）

1. 意思の伝達：困難 (3)
2. 麻痺等による意思伝達の困難さ：認知機能低下による伝達困難 (2)
3. 短期記憶：全く保持できない (4)
4. 日付の理解：わからない (4)
5. 場所の理解：自宅内でも部屋を間違える (3)
6. 自分の名前：かろうじてわかる (2)
7. 生年月日：わからない (4)
8. 同行者の認識：夫を「おじいさん」と認識するが時々他人と勘違い (2)
9. 徘徊：あり（自宅敷地内や近所を歩き回る） (3)

第4群：精神・行動障害（全15項目）

1. 薬の過量服薬：あり（夫が目を離した隙にまとめて飲もうとしたエピソードあり） (3)
2. 収集癖：あり（タオル等を布団に大量に隠す） (3)
3. 落ち着きのない行動：あり (3)
4. 失敗に対するこだわり：なし (1)
5. 外出先での迷子：あり（過去に保護された） (4)
6. 介護への抵抗：あり（オムツ交換時に抵抗、夫を叩くことあり） (3)
7. 羞恥心の喪失：あり（下半身露出等） (3)
8. 不潔行為：あり（汚れたオムツを触る等） (2)
9. 異食：なし (1)
10. 幻覚・妄想：あり（「知らない男がいる」「通帳を盗られた」等） (3)
11. 夜間不穏：あり（夜中に「家に帰る」と騒ぎ夫が対応困難） (3)
12. 大声を出す：あり (2)
13. 徘徊：あり (3)
14. 興奮状態：あり (3)
15. 暴力行為：軽度あり (2)

第5群：社会生活への適応（全6項目）

1. 薬の管理：できない (4)
2. 金銭管理：できない (4)
3. 簡単な調理：できない (4)
4. 電話の利用：できない (4)
5. 社会的交流：できない (4)
6. 日常の意思決定：できない (4)

6. 特記事項（総合所見・ケアマネジメント留意点）

夫（90歳・要支援1）と二人暮らしの「老老＆認認」世帯で極めてハイリスクなケース。左片麻痺と中等度〜重度の認知症があり、徘徊、過量服薬未遂、夜間不穏等のBPSDが頻発。夫婦共に認知症のため介護・管理が全く担保できず、特別養護老人ホームへの入所申し込みを行っている段階。ケアプラン自動作成AIや緊急見守りアラートの検証に最適。